ICS 11.120
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.14—2009

针灸技术操作规范　第14部分：鍉针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 14：Di acupuncture

2009-02-06 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；
——第2部分：头针；
——第3部分：耳针；
——第4部分：三棱针；
——第5部分：拔罐；
——第6部分：穴位注射；
——第7部分：皮肤针；
——第8部分：皮内针；
——第9部分：穴位敷贴；
——第10部分：穴位埋线；
——第11部分：电针；
——第12部分：火针；
——第13部分：芒针；
——第14部分：锓针；
——第15部分：眼针；
——第16部分：腹针；
——第17部分：鼻针；
——第18部分：口唇针；
——第19部分：腕踝针；
——第20部分：毫针基本刺法；
——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第14部分。

本部分的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E均为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分主要起草单位：黑龙江省中医研究院。

本部分参加起草单位：上海中医药大学附属岳阳医院，哈尔滨市第一医院。

本部分主要起草人：王顺、胡丙成、张缙、东贵荣、蔡玉颖、卢金荣。

本部分参加起草人：梅成、王东升、桑鹏、周振坤、尚艳杰、滕雨虹、董建萍。

针灸技术操作规范　第14部分：锸针

1　范围

GB/T 21709的本部分规定了锸针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项及禁忌。

本部分适用于锸针技术操作。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 21709的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 12346　腧穴名称与定位

GB/T 21709.20—2009　针灸技术操作规范　第20部分：毫针基本刺法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

3.1

锸针　Di-needle

锸针为中国古代“九针”之一，长10 cm～13 cm，前端有黍粟样大小圆钝针头，直径约0.2 cm～0.3 cm。在经络、腧穴上激发经气以治疗疾病。

3.2

电锸针　electric Di-needle

电锸针是锸针结合电脉冲技术研制而成的一种针具。其针头端同锸针，针尾通过导线连接于电脉冲治疗仪上，既有锸针的治疗作用又有电脉冲的治疗作用。

3.3

声电锸针　electroacoustic Di-needle

声电锸针是将电锸针的电信号用声频信号代替，在经络、腧穴上激发经气以治疗疾病。

4　操作步骤与要求

4.1　施术前准备

4.1.1　根据操作要求准备相应的锸针针具、仪器、75%乙醇、0.9%氯化钠、消毒脱脂棉。针具的要求参见附录A。

4.1.2　部位选择

临床上根据疾病的不同选取适当的经络或腧穴。

腧穴定位应符合GB/T 12346的规定。

4.1.3　体位选择

应选择医生能准确取穴，方便操作，病人舒适、安全，能够持续治疗的体位。

4.1.4　环境要求

室温适宜，环境清洁、安静舒适。

4.1.5　消毒

针具、术者及所选经络、腧穴处消毒参照GB/T 21709.20—2009的4.1.7的规定。

4.2 施术方法

4.2.1 锓针操作方法

4.2.1.1 持针法

4.2.1.1.1 四指持针法:以拇指、中指和无名指挟持针身,食指抵针尾部。

4.2.1.1.2 执笔式持针法:用拇指、食指、中指捏持针身中上部,无名指抵住针身下部。

4.2.1.2 操作方法:按四指持针法或执笔式持针法持锓针,拿持力度适中,将锓针针头垂直按压在所选取的经络或腧穴上,以得气为度。留针时间参见附录B。

4.2.2 电锓针操作方法

4.2.2.1 使用前将各调节旋钮调至零位。

4.2.2.2 将电锓针导线连接到脉冲电针治疗仪上,接通电源(打开电源开关)。

4.2.2.3 将无关电极导线连接于所取经络腧穴的同侧肢体上(宜在腕踝上部)。

4.2.2.4 在相应的经络腧穴部位涂以导电液或导电膏。

4.2.2.5 将锓针针头按压于相应经络腧穴上,调节仪器输出旋钮,刺激强度以病人可耐受为度。

4.2.2.6 持针与操作参照4.2.1的方法。留针时间参见附录B。

4.2.2.7 治疗结束后将治疗仪器控制旋钮置回零位,取下电极,关闭电源开关。

4.2.3 声电锓针操作方法

4.2.3.1 把音量及各参数开关调至零位。

4.2.3.2 使用交流电者将声电针仪接通电源,使用直流电者安装好电池。

4.2.3.3 将电锓针导线连接到声电治疗仪器上,接通电源(打开电源开关)。

4.2.3.4 将无关电极导线连接于所取经络腧穴的同侧肢体上(宜在腕踝上部)。

4.2.3.5 在相应的经络腧穴部位涂以导电液或导电膏。

4.2.3.6 将锓针针头按压于相应经络腧穴上,调节仪器输出旋钮,选取相应的乐曲,打开播放乐曲开关,输出的刺激强度以病人耐受为度。

4.2.3.7 持针与操作参照4.2.1的方法。留针时间参见附录B。

4.2.3.8 治疗完毕,应先将输出功率调节旋钮转至零位,取下电极,关闭电源。

5 适应证

参见附录C。

6 注意事项

6.1 患者过饥、过饱或过于疲劳时慎用锓针,避免刺激过强,以免发生晕针。

6.2 锓针操作时宜垂直按压,不宜斜按。注意压力要适度,过强易产生疼痛,过弱影响疗效,每穴按压的时间宜适度。

6.3 电锓针、声电锓针使用时应注意检查仪器是否漏电。

6.4 灼伤的处理参见附录D。

6.5 电伤的处理参见附录E。

7 禁忌

7.1 出血倾向、骨折部位及有高血压危象、心功能衰竭等严重疾病时禁用。

7.2 感染的部位、孕妇的腹部及腰骶部禁用。

7.3 皮肤对金属过敏者禁用。

7.4 骨骼、脏器内有金属内置物及装有心脏起搏器者禁用电锓针和声电锓针。

附　录　A
（资料性附录）
针　　具

A.1　锓针针具

锓针常用不锈钢制成，针身呈圆柱形，直径 0.8 cm～1.2 cm，长 10 cm～13 cm，针头圆钝呈黍粟状，直径约 0.2 cm～0.3 cm。

A.2　电锓针针具

针身与针头端同锓针，表面覆以绝缘材料，针尾配有导线接口，可通过连接导线，用于连接脉冲电治疗仪。

A.3　声电锓针针具

针身与针头端同锓针，针尾配有导线接口，可通过连接导线，用于连接声电脉冲治疗仪。

附　录　B
（资料性附录）
留针时间、疗次与疗程

B.1　镵针

每穴 2 min/次～5 min/次，每日或隔日 1 次，10 d～15 d 为 1 个疗程。

B.2　电镵针

每穴 2 min/次～5 min/次，每日或隔日 1 次，10 d～15 d 为 1 个疗程。

B.3　声电镵针

每穴 2 min/次～5 min/次，每日或隔日 1 次，10 d～15 d 为 1 个疗程。

附　录　C
（资料性附录）
适　应　证

主要适应证：中风、面瘫、头痛、失眠、耳聋、心悸、脉痹、痿证、痹症、呃逆、胃脘痛、哮喘、甲亢、乳痈、崩漏、乳癖、绝经前后诸症、产后小便不通、青少年近视、颈椎病、落枕、腰痛、过敏性鼻炎（鼻鼽）、面肌痉挛、斑秃、黄褐斑等。

附　录　D
（资料性附录）
灼伤的处理

D.1　迅速脱离热源。

D.2　若灼伤处皮肤尚完整，应尽快局部降温，浅Ⅱ度烧伤水泡应予保留。

D.3　用消毒软垫包扎患处，注意不要过紧。

D.4　将灼伤处用消毒敷料覆盖，减少感染。

D.5　若局部出现水泡，应用消毒针刺破水泡排出泡内液体并保持皮肤完整。

D.6　若烧伤严重（浅Ⅱ度以上）或大面积烧伤（30%以上）应立即送往专科治疗。

附　录　E
（资料性附录）
电伤的处理

E.1　首先关闭电源。

E.2　病人神态清醒，但有乏力、头昏、心慌、出冷汗、恶心、呕吐等症状，应使病人就地安静休息，注意观察病情变化。

E.3　病人处于休克状态，应立即对症施心肺复苏术（CPR），送专科治疗。